

Chapitre 1

Panorama de la protection sociale

F. Candau (UPPA-TREE)

Les politiques sociales, une définition

- Les politiques sociales prennent en charge une **baisse de revenus** ou une **hausse de dépenses** liées à des risques socio-économiques, sanitaires, ou à des événements du cycle de vie (chômage, maladie, vieillesse).
- La prise en charge repose sur un principe de **solidarité**, intragénérationnelle (les actifs en emploi financent les prestations chômage) ou intergénérationnelle (des actifs vers les retraités).

Périmètre et définition

- **Périmètre de ce cours** : plus large que la Sécurité sociale (maladie, accidents du travail, vieillesse, famille, autonomie depuis 2020). S'y ajoutent l'assurance chômage, les aides de l'État et des collectivités, les mutuelles.
- Plus étroit que l'État providence, dont sont exclues ici la législation du travail, la fiscalité et l'éducation.
- Ce périmètre est celui des **assurances sociales**, définies par deux traits : la loi rend l'affiliation obligatoire, le financement ne dépend pas du risque propre de chacun. L'assurance privée est facultative et tarifée selon le risque.

Dans la presse

Ces dépenses font débat.

- « Crise budgétaire : 56 % des Français veulent couper dans les aides sociales » (*JDD*, avril 2025)
- « Aides sociales : ces milliards d'euros que les Français ne réclament pas » (*franceinfo*, octobre 2022)
- « Inégalités, redistribution, pouvoir d'achat... Le modèle social français est efficace, mais coûteux, selon l'Insee » (*franceinfo*, avril 2026)
- « Prestations sociales : en France, la redistribution permet de diminuer d'un tiers le nombre de personnes pauvres » (*franceinfo*, août 2024)

Les six risques débattus dans les médias (1/2)

Les comptes de la protection sociale distinguent six catégories de risques.

- **Santé** (maladie, invalidité, accidents du travail)
 - « Le déficit de l'Assurance-maladie pourrait atteindre 41 milliards d'euros en 2030 » (*franceinfo*, juin 2025)
 - « Hôpital : de nombreux services d'urgences contraints de fermer faute de soignants » (*franceinfo*, août 2024)
 - « Arrêts maladie : la suspicion plutôt que la prévention » (*Politis*, avril 2026)
- **Vieillesse-survie** (retraites, minimum vieillesse, dépendance, réversion)
 - « Privé sacrifié, fonctionnaires choyés : le véritable scandale des retraites » (*Le Figaro*)
 - « En Allemagne, la retraite par capitalisation a produit plus de pauvreté que de capital » (*Alternatives économiques*, mars 2024)
- **Maternité-famille**
 - « Natalité : le nombre de bébés en France est le plus bas depuis 1945 » (*franceinfo*, janvier 2026)
 - « Non, il n'y a pas 42 % d'allocations familiales versées aux étrangers » (*franceinfo*, Désintox)

Les six risques débattus dans les médias (2/2)

- **Emploi** (indemnisation du chômage, préretraites, insertion)
 - « L'exécutif se prépare à durcir à nouveau les règles de l'assurance-chômage » (*Public Sénat*, février 2024)
 - « Les demandeurs d'emploi sont les boucs émissaires du gouvernement » (*Public Sénat*, mai 2024)
- **Logement**
 - « Logement social : "C'est inédit, on n'a jamais eu autant de demandeurs en France" » (*franceinfo*, octobre 2023)
 - « La réforme des APL a fait plus de perdants que de gagnants, selon un rapport du Sénat » (*Public Sénat*, novembre 2021)
- **Pauvreté et exclusion sociale** (dont le RSA)
 - « "Arrêter l'assistanat" : les députés LR réclament une commission d'enquête sur les aides sociales » (*JDD*, 2025)
 - « Plus d'un tiers des personnes qui devraient bénéficier du RSA ne le touchent pas » (*franceinfo*, 2024)

Plan

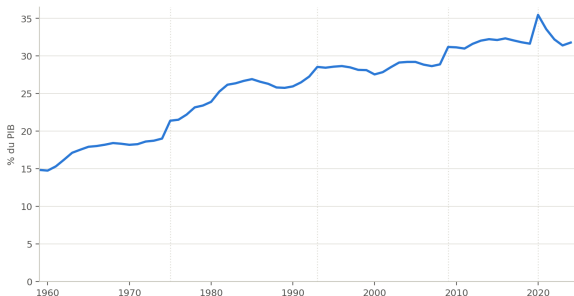
1. Les dépenses de protection sociale et leur moteur démographique.
2. Les deux logiques de couverture, contributive et universelle.
3. Les branches françaises, leurs règles et leur financement.
4. Trois mécanismes communs à toutes les branches.

Section 1

Dépenses

Un tiers du PIB

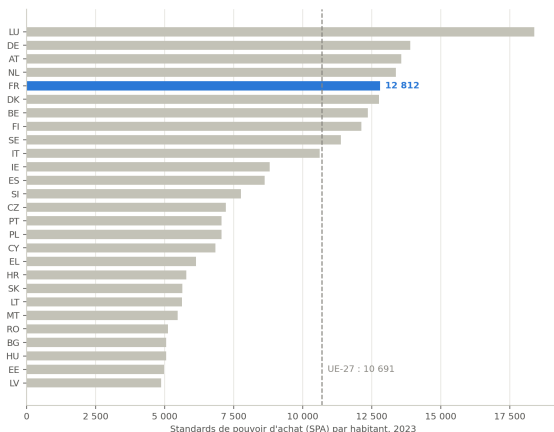
- La part des prestations dans le PIB a plus que doublé, de **14,8 % en 1959** à **31,8 % en 2024**, soit environ **13 600 euros par habitant en 2024**.



Traits verticaux : années de contraction du PIB (1975, 1993, 2009, 2020). Sources : DREES, comptes de la protection sociale ; INSEE.

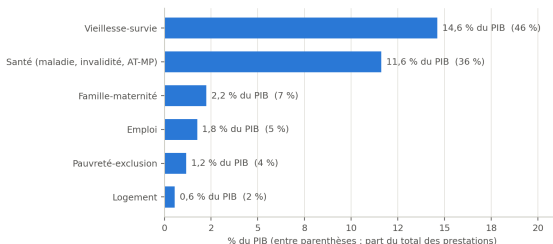
Une exception française ?

- La France est 5^e sur 27 par habitant, mais la première de l'Union en % du PIB.



Les dépenses par risque

- Vieillesse-survie (46 %) et santé (36 %) concentrent plus de 80 % des prestations.



Source : Eurostat, ESSPROS.

Section 2

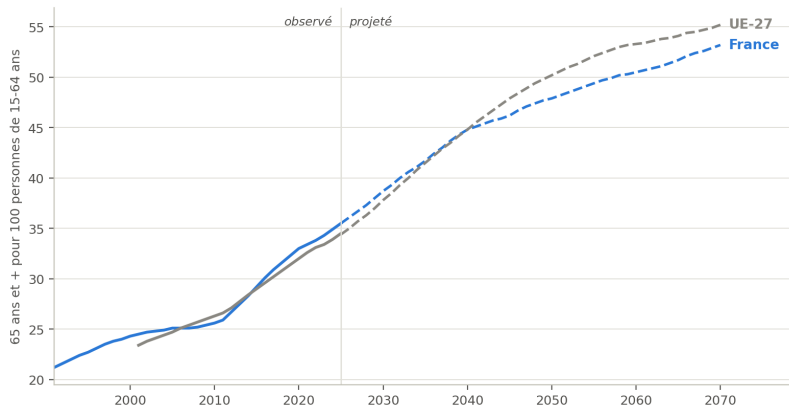
Vieillessement

Le ratio de dépendance des personnes âgées

$$\text{ratio de dépendance des personnes âgées} = \frac{\text{personnes de 65 ans et plus}}{\text{personnes de 15 à 64 ans}} \times 100$$

- Il mesure approximativement le nombre de personnes que chaque centaine d'actifs potentiels doit financer.
- Ce ratio a fortement augmenté (figure suivante).
- La France comptait environ cinq personnes d'âge actif par personne âgée en 1990, et elle en comptera moins de deux en 2070.

Ratio de dépendance des 65 ans et plus



En 2025, dernière année observée, la France compte 36 personnes âgées pour 100 actifs. Source : Eurostat.

Hypothèses des projections

- Le vieillissement est général en Europe. La France y échappe un peu en fin de période, grâce à une fécondité longtemps plus élevée.
- **À 15 ans** : l'incertitude vient presque uniquement du solde migratoire.
- **À l'horizon 2070** : la fécondité devient l'hypothèse la plus sensible, devant les migrations et l'espérance de vie.
- **L'ordre de grandeur reste robuste** : les personnes qui auront 65 ans en 2050 sont déjà nées.
- Ce fait structure tout le cours, des retraites (chapitre 3) à la santé et la dépendance (chapitre 4), jusqu'au financement (chapitre 8).

Section 3

Logiques

Le modèle contributif (Bismarck)

- Deux “systèmes” sont traditionnellement comparés.
- Dans un système contributif, aussi dit Bismarkien, la protection sociale est une assurance liée au travail, qui couvre ceux qui exercent une activité et cotisent, ainsi que leur famille. Le droit à la prestation naît de la cotisation.
- Son objet est de remplacer un revenu d’activité perdu => la prestation est proportionnelle au salaire antérieur. On fait perdurer les inégalités salariales.
- La prestation est un “salaire différé”, et non un transfert de la collectivité.
- La gestion revient à des caisses distinctes de l’État, où siègent employeurs et salariés (assurances sociales allemandes des années 1880, lois françaises de 1898-1930, Sécurité sociale de 1945).

Le modèle universel (Beveridge)

- Le modèle universel, dit beveridgien, fait de la protection sociale un droit attaché à la personne, indépendamment de son activité, et le droit à la prestation naît de l'appartenance à la collectivité.
- Son objet est de garantir à chacun un socle de ressources et l'accès aux soins, si bien que la prestation est **forfaitaire**, la même pour tous quel qu'ait été le revenu antérieur.
- Financement par l'impôt.
- La gestion revient à l'État (rapport Beveridge de 1942, pays nordiques).

Quatre dimensions pour situer un système

	Contributif (Bismarck)	Universel (Beveridge)
Accès aux droits	Emploi et cotisation	Résidence, citoyenneté
Prestations	Proportionnelles au salaire	Forfaitaires
Financement	Cotisations sur les salaires	Impôt
Gestion	Caisses, partenaires sociaux	Administration de l'État
Redistribution	Horizontale, entre risques	Verticale, entre revenus

- Esping-Andersen (1990) classe les systèmes selon le degré d'indépendance à l'égard du marché qu'ils procurent, la **démarchandisation**, et distingue trois régimes, **libéral**, **social-démocrate** et **conservateur-corporatiste**.

Section 4

Branches

L'organisation française

Le système français s'organise en régimes, branches et caisses.

- Il existe un grand nombre de **régimes** de sécurité sociale. Le **régime général** couvre les salariés du secteur privé et verse 40-45 % des prestations.
- Le régime général est structuré en cinq **branches**, maladie, vieillesse, famille, accidents du travail et maladies professionnelles, autonomie depuis 2020, chacune gérée par une caisse nationale tenue d'assurer son équilibre financier (Cnam, Cnaf). L'idée initiale était de séparer la gestion des risques.
- Le **chômage** et l'insertion sont gérés hors Sécurité sociale.

Les branches selon la grille

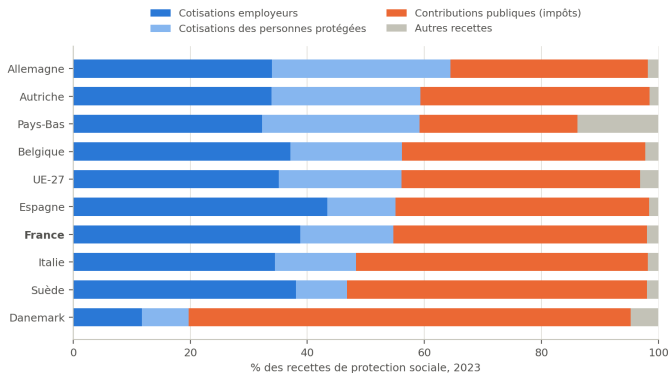
Partie du modèle contributif en 1945, la France a ouvert plusieurs branches sur la résidence et fiscalisé une partie de son financement. Sa position dans la grille dépend de la branche.

Branche	Ouverture des droits	Règle principale	Financement
Maladie	Résidence depuis 2016	Tarif de convention, ticket modérateur	cotis. employeurs 38 %, CSG 23 %, impôts 29 %
Retraites	Cotisation, carrière	64 ans, 43 annuités, 25 meilleures années	cotis. employeurs 32 %, salariés 22 %, impôts 10 %, CSG 7 %
Chômage	6 mois sur 24	≈ 57 % du brut, 18 mois au plus avant 55 ans	contributions employeurs 60 %, CSG 38 %
Famille	Résidence, enfants	Dès le 2 ^e enfant, modulées depuis 2015	cotis. employeurs 63 %, CSG 24 %, impôts 10 %
Accidents du travail	Emploi salarié	Réparation forfaitaire, cotisation selon sinistralité	cotis. employeurs 92 %
Minima sociaux	Résidence, ressources	Prestation différentielle	impôt
Autonomie	Résidence, perte d'autonomie	Plan d'aide, participation selon revenu	CSG 89 %, impôts 11 %

Un financement qui passe de plus en plus par les impôts

- **Cotisations** : assises sur les salaires, elles ouvrent des droits. C'est le financement d'origine.
- **Fiscalisation** : depuis les années 1980-1990, recours croissant à l'impôt (CSG en 1991, CRDS en 1996, impôts et taxes affectés aux branches).
- Part des cotisations dans les recettes : **80 % en 1990, 55 % en 2023.**
- Effets sur le coût du travail et l'emploi : chapitre 8.

La part des cotisations en Europe



Partie d'un financement aussi contributif que celui de l'Allemagne (64 % de cotisations), la France (55 %) est désormais à la moyenne européenne ; le Danemark est à 20 %. Source : Eurostat, ESSPROS.

Un système hybride

La France a commencé contributive et s'est universalisée sans jamais changer de modèle d'ensemble.

- **Dualisation** (Palier, 2005) : une sphère d'assurance contributive pour les risques du travail, une sphère universelle et fiscalisée pour la maladie, la famille et la pauvreté.
- **Hybridation** (Elbaum, 2011) : la France ne relève ni d'un modèle ni de l'autre, branche par branche.
- Le financement, proportionnel aux salaires au début des années 1990, est devenu progressif sous l'effet de la CSG et des allègements sur les bas salaires (Zemmour, 2015).
- L'hybridation n'est pas propre à la France, mais elle y est marquée : point de départ plus contributif, point d'arrivée plus fiscalisé.

Section 5

Mécanismes

Aléa moral et sélection adverse

Trois mécanismes reviennent dans chaque chapitre.

- **Aléa moral** : la couverture d'un risque pourrait modifier le comportement de l'assuré, qui n'en supporte plus le coût.
 - Un patient remboursé consomme-t-il plus de soins ? (chap. 4)
 - Un chômeur indemnisé cherche-t-il moins activement ? (chap. 6)
- **Sélection adverse** : l'assuré connaît son risque mieux que l'assureur, qui tarife un risque moyen.
 - À ce tarif, les bons risques se retirent, le coût moyen monte, la prime suit.
 - L'affiliation obligatoire empêche ce retrait, première justification des systèmes obligatoires (rentes viagères chap. 3, maladie chap. 4, chômage chap. 6).

La justice de la redistribution

- La protection sociale redistribue, des bien-portants vers les malades, des actifs vers les retraités, des hauts revenus vers les bas revenus.
- Jusqu'où doit aller cette redistribution ?
- Garantir un minimum, égaliser les chances au départ ou corriger les résultats à l'arrivée ?
- Compenser les inégalités non choisies (naissance, maladie) sans compenser celles qui résultent de choix ?
- Le chapitre 7 présente les théories qui répondent à ces questions, le chapitre 8 la répartition de la charge.

Section 6

Conclusion

Conclusion

- **Un tiers du PIB**, vieillesse et santé en absorbant plus de 80 % ; part doublée depuis 1959, tirée par le vieillissement (de 36 à 53 personnes âgées pour 100 actifs en 2070).
- **Deux configurations types**, contributive et universelle, qu'aucun système ne présente plus à l'état pur.
- **La France, partie contributive en 1945**, a ouvert la maladie, la famille et la pauvreté à la résidence et remplacé une partie des cotisations par la CSG : ses branches ne relèvent pas de la même logique.
- **Trois mécanismes** dans chaque branche : l'aléa moral et la sélection adverse limitent ce qu'une assurance peut couvrir, les théories de la justice répondent à la question de son étendue.
- Chapitre 2, l'histoire ; chapitres 3 à 6, les branches ; chapitres 7 et 8, la redistribution et son financement.

Les ordres de grandeur à retenir

- Prestations de protection sociale : environ **un tiers du PIB** (31,8 % en 2024), contre 14,8 % en 1959, soit environ **13 600 euros par habitant**.
- **Vieillesse-survie (46 %) et santé (36 %)** concentrent plus de 80 % des prestations.
- La France est **au sommet de l'UE en % du PIB**, mais 5^e par habitant.
- Part des cotisations dans les recettes : de **80 % en 1990 à 55 %** aujourd'hui.
- Ratio de dépendance des 65 ans et plus : d'environ **36 aujourd'hui à 53 en 2070**.

Section 7

Vérification des connaissances

Questions de cours

- ❶ Qu'est-ce qui distingue une assurance sociale d'une assurance privée ?
- ❷ En quoi le périmètre de la protection sociale diffère-t-il de celui de la Sécurité sociale et de celui de l'État providence ?
- ❸ Distinguez solidarité intragénérationnelle et solidarité intergénérationnelle, avec un exemple de chacune.
- ❹ Comment se répartit la dépense de protection sociale française entre les grands risques ?
- ❺ Par quels mécanismes le vieillissement démographique pèse-t-il sur les dépenses sociales ?

Question de réflexion

- ❶ La protection sociale française relève-t-elle encore d'un modèle contributif ?